

La construction du crack à Paris comme un « problème » épidémiologique, de prise en charge et d'écologie urbaine

Marie Jauffret-Roustide, Sayon Dambélé, Camille de Azevedo Martinho Porto

DANS **PSYCHOTROPES** 2023/4 (VOL. 29), PAGES 7 À 29

ÉDITIONS **DE BOECK SUPÉRIEUR**

ISSN 1245-2092

ISBN 9782807380028

DOI 10.3917/psyt.294.0007

Article disponible en ligne à l'adresse

<https://www.cairn.info/revue-psychotropes-2023-4-page-7.htm>



CAIRN.INFO
MATIÈRES À RÉFLEXION

Découvrir le sommaire de ce numéro, suivre la revue par email, s'abonner...

Flashez ce QR Code pour accéder à la page de ce numéro sur Cairn.info.



Distribution électronique Cairn.info pour De Boeck Supérieur.

La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.

La construction du crack à Paris comme un « problème » épidémiologique, de prise en charge et d'écologie urbaine

The construction of crack cocaine
in Paris as an epidemiological,
care, and urban ecology "problem"

Marie Jauffret-Roustide

Sociologue et politiste, chargée de recherche Inserm au Centre d'étude
des mouvements sociaux (Inserm U1276/CNRS UMR8044/EHESS),
54 bd Raspail, 75006 Paris,
marie.jauffret-roustide@inserm.fr.

Sayon Dambélé

Ingénieur d'études, Cermes3

Camille de Azevedo Martinho Porto

Post-doctorante en anthropologie à l'Université de Rio de Janeiro, Brésil

Résumé : *La question du crack est construite en France comme un problème public, décrit le plus souvent à partir d'un double cadrage présenté comme dichotomique, celui de la sécurité publique qui s'opposerait à celui de la santé publique. Dans cet article, nous nous proposons d'analyser combien ce cadrage est plus complexe que la simple distinction entre les dimensions sécuritaire et sanitaire. Nous souhaitons également mettre en évidence la diversité des acteurs impliqués et de leurs*

mobilisations pour tenter de répondre à la question du crack comme problème public. Nous montrons comment cette question est l'objet de cadrages multiples qui impliquent des perspectives épidémiologiques, de prise en charge et d'écologie urbaine, traversées par les logiques de santé publique et de sécurité publique.

Abstract: In France, the issue of crack cocaine is framed as a public problem, most often described in terms of a double dichotomy: public safety versus public health. In this article, we propose to analyze the extent to which this framing is more complex than the simple distinction between the security and health dimensions. We also aim to highlight the diversity of the actors involved and their mobilization to address the issue of crack cocaine as a public problem. We show how this issue is the subject of multiple framings involving epidemiological, care, and urban ecology perspectives, permeated by public health and public safety logics.

Mots clés : crack, problème public, sociologie, santé publique, sécurité publique, politique, épidémiologie, écologie urbaine

Keywords: crack, public problem, sociology, public health, public safety, policy, epidemiology, urban ecology

Introduction

La détention et l'usage de drogues étant interdits par la loi du 31 décembre 1970 en France, la consommation de drogues se déroule le plus souvent dans un cadre privé afin de pouvoir être dissimulée. Toutefois, certains publics qui consomment des substances psychoactives et qui n'ont pas de logement peuvent être réduits à « publiciser » leur usage. Ces actes de consommation dans l'espace public peuvent par ailleurs être réglementés, voire interdits par la loi, même pour certaines substances licites telles que l'alcool. En effet, la consommation d'alcool est interdite à proximité de certains lieux (les écoles par exemple) et l'ivresse en public constitue un délit. Quand ces actes de consommation en public se concentrent sur un espace géographique

donné et qu'ils sont associés à des actes de vente, ce phénomène est alors qualifié de scène ouverte de drogues (Bless *et al.*, 1995). Ces « scènes ouvertes » de drogues, qui concentrent usagers et dealers, apparaissent au tournant des années 1970 et 1980. Elles vont être popularisées par les médias, et notamment par le biais de la presse ou de films. Citons par exemple les pratiques d'injection sur la *Platzspitz* à Zurich en Suisse ou à l'*Îlot Chalon* à Paris en France, et l'usage de crack dans les rues du *Bronx* à New York aux États-Unis. Parcs, gares, cages d'escalier, parkings, toilettes publiques, rues étroites, bâtiments et terrains abandonnés sont autant d'espaces qui peuvent être investis pour consommer des drogues individuellement ou collectivement. Les fumeurs de crack constituent des figures modernes de la précarité, une sorte de « *lumpenproletariat* » urbain, tels que les qualifie l'anthropologue américain Philippe Bourgois (Bourgois, 1992 et 1998). Ces figures sont stigmatisées et se situent au plus bas de la hiérarchie sociale au sein même du monde social des usagers de drogues. De plus, leur présence peut être vécue comme un trouble à l'ordre public. Les corps décharnés, les regards hagards, les démarches titubantes des consommateurs de crack constituent des images qui peuvent être perturbantes pour les usagers de l'espace public (Jauffret-Roustide, 2011.) Une partie d'entre eux vont alors interpellier les responsables politiques pour les pousser à agir, à titre individuel ou dans le cadre de collectifs.

Depuis une trentaine d'années en France, la présence de scènes ouvertes de crack contribue à rendre visible la question du crack dans le débat public et à construire progressivement le crack comme un problème public. Ce cadrage du phénomène comme un « problème public » démarre en France à partir du milieu des années 1980, quand les présences concomitantes du crack et de figures d'usagers ont été identifiées dans le Nord-Est de Paris. Les chercheurs Mohamed Toussirt et François-Rodolphe Ingold datent en effet l'arrivée du crack dans la capitale en 1987 d'après leurs recherches ethnographiques et épidémiologiques (1994), même si cette substance était consommée dans les territoires d'outre-mer quelques années avant en 1982, selon les travaux du clinicien Aimé Charles-Nicolas (Charles Nicolas, 1997). Dans sa postface de l'ouvrage de Joseph Gusfield sur *la culture des problèmes publics*, le sociologue Daniel Cefaï (2019) définit un problème public comme un problème social – dont les conséquences telles que le danger ou le risque font que cette question n'est plus seulement un « problème individuel » mais un « problème

social et collectif ». La demande de définition et de résolution d'un problème public va alors concerner une diversité de publics (incluant ici sur la question du crack les consommateurs eux-mêmes et des riverains, mais également les forces de police, les politiques ainsi que des médecins, travailleurs sociaux, activistes...) et la société dans son ensemble. Cette question va donner lieu à une intense activité de coopération, de communication et de négociations entre les acteurs, les organisations et les institutions, mais aussi de nombreuses argumentations, dénonciations et revendications, ce qui va contribuer à la publicisation de cette question comme problème public. Selon Daniel Cefaï (2017), on ne peut comprendre le processus de publicisation d'une question qu'à partir de ses points d'ancrage dans une situation problématique, et des techniques d'intervention, croyances pratiques et leviers institutionnels développés pour la résoudre. La question du crack est construite en France comme un problème public, décrit le plus souvent à partir d'un double cadrage présenté comme dichotomique, celui de la sécurité publique qui s'opposerait à celui de la santé publique. Dans cet article, nous nous proposons d'analyser combien ce cadrage est plus complexe que la simple distinction entre les dimensions sécuritaire et sanitaire et nous souhaitons également mettre en évidence la diversité des acteurs impliqués et de leurs mobilisations pour tenter de répondre à la question du crack comme problème public. Nous montrons comment cette question est l'objet de cadrages multiples qui impliquent des perspectives épidémiologiques, de prise en charge et d'écologie urbaine, traversées par les logiques de santé publique et de sécurité publique.

Méthodologie

Notre article s'appuie principalement sur deux recherches ethnographiques menées autour de l'usage de crack comme problème public à Paris entre 2017 et 2021, une recherche exploratoire menée par l'Inserm pour la Mission Métropolitaine de Prévention des Conduites à Risque (MMPCR) puis une étude intitulée Crack en Île-de-France, menée par l'Inserm en collaboration avec l'Observatoire Français des Drogues et des Tendances Addictives (OFDT) (en charge de la partie trafics de l'étude) pour la MPPCR, l'Agence Régionale de Santé (ARS) d'Île-de-France et la Mildeca-Île-de-France. Les deux premiers auteurs de cet article (Marie Jauffret-Roustide et Sayon

Dambélé) ont respectivement supervisé et contribué à ces deux recherches¹. Les deux recherches s'appuient sur des observations ethnographiques, des entretiens semi-directifs menés auprès de personnes consommatrices de crack et de professionnels de réduction des risques et du traitement. Cet article est le produit du regard croisé entre trois chercheurs travaillant sur la thématique de l'usage de crack car il est également né de la rencontre entre une chercheuse sociologue et politiste travaillant sur ces questions depuis près de 30 ans avec un ancrage très fort à Paris (Marie Jauffret-Roustide), un ingénieur d'études ayant travaillé sur les questions de crack durant 5 ans en combinant observations ethnographiques et entretiens (Sayon Dambélé) et une chercheuse sociologue et anthropologue résidant au Brésil et ayant passé un an et demi à Paris dans le cadre de son terrain de thèse, développé à partir d'une ethnographie dans trois structures de réduction des risques (Camille Porto)².

Les données mobilisées dans l'article sont celles de l'étude Crack en Île-de-France qui a été menée entre 2019 et 2021, précédée par une étude exploratoire réalisée entre 2017 et 2018. Des entretiens ont été réalisés auprès de 52 personnes consommatrices de crack et de 56 professionnels. Les usagers de crack ont été recrutés majoritairement au sein des CAARUD et CSAPA à Paris et en Seine-Saint-Denis au sein des structures. Nous avons également mis en place une technique type « boule de neige » (recrutement des usagers à partir des premiers répondants qui proposent l'enquête à des membres de leur réseau, et non à partir d'un tirage au sort aléatoire) pour approcher des personnes insérées, consommatrices de crack, invisibles dans les CAARUD et CSAPA à Paris et en Seine-Saint-Denis. Certains usagers ont également été recrutés sur les scènes de consommation. Les guides d'entretien s'inscrivent dans une approche biographique. Cette approche a inclus un questionnement sur les pratiques de consommation de produits et leur évolution au cours du temps (initiation,

-
1. Dans le cadre du volet Trajectoires, mobilités et besoins de l'étude Crack en Île-de-France réalisée par l'Inserm, Candy Jangal, Mireille Le Breton et Mathieu Lovera ont participé à la collecte des données, Christine Calderon aux retranscriptions et Isabelle Cailbault au codage et à l'indexation des données. Agnès Cadet-Taïrou, Michel Gandilhon et Grégory Pfau ont coordonné la partie trafics du rapport, pour l'OFDT.
 2. La recherche développée par Camille Porto est financée par FAPERJ – Fondation d'appui à la recherche de l'État de Rio de Janeiro, SEI Process 260003/019659/2022.

inscription éventuelle dans des trajectoires de dépendance), la caractérisation des profils sociaux, le recours éventuel des usagers aux structures, leurs manières d'investir l'espace public et leur mobilité. Une attention particulière a été accordée aux parcours des usagers vivant en situation de précarité afin de savoir comment leurs parcours et itinéraires se construisent au quotidien, afin de caractériser leur mobilité et leurs choix de mobilité (pourquoi sont-ils présents dans certains espaces plutôt qu'ailleurs), et les structures qu'ils fréquentent (incluant les structures médico-sociales mais également les structures sociales). L'objectif de ces entretiens était de pouvoir caractériser les trajectoires, les profils et la mobilité des usagers de crack. Les entretiens ont également intégré les besoins en matière de prise en charge et de réduction des risques. Nous avons exploré les besoins dans le domaine sanitaire, social et relationnel, en nous efforçant de recueillir les discours spontanés des usagers et de les laisser hiérarchiser eux-mêmes leurs besoins. Nous avons dans un deuxième temps relancé les usagers en leur demandant de s'exprimer sur les dispositifs existants. Cette méthode empirique s'appuyant avant tout sur les discours exprimés par les personnes permet de mettre à distance les présupposés que le chercheur peut avoir dans le domaine et de faire émerger des pistes nouvelles. Des entretiens ont également été réalisés auprès des professionnels, exerçant à Paris et en Seine-Saint-Denis, avec une diversité accordée aux lieux de recrutement (CAARUD, CSAPA, hôpitaux, maraudes sociales, maraudes psychiatriques, RATP, dispositifs de droit commun...). Ces entretiens portaient sur des thématiques proches de celles explorées auprès des usagers, en particulier la caractérisation des profils des usagers et de leur évolution au cours du temps, leurs besoins, et une cartographie des services et améliorations en termes de localisation géographique. Des observations ethnographiques ont également été effectuées tout au long de la recherche, à la fois sur les scènes de consommation de crack bien identifiées dans le Nord-Est parisien ainsi que sur d'autres lieux repérés comme des espaces de visibilité du crack en émergence.

Afin de capter la complexité de la publicisation du phénomène du crack et les différents cadrages visant à sa production comme problème public, notre analyse a inclus une étude de la presse menée de 1986 à 2023 (1560 articles référencés et analysés), un travail d'archive des travaux scientifiques et associatifs produits sur la même temporalité. Le cadre analytique de ces données a été enrichi grâce au dialogue avec Camille Porto qui a réalisé sa thèse sur la question de

la réduction des risques en lien avec l'usage de crack à Paris durant la même période que celle de la réalisation de l'enquête Crack en Île-de-France.

***Le crack comme problème épidémiologique :
chiffrer le phénomène et caractériser
des profils socio-démographiques***

L'estimation du nombre d'usagers de crack en France ainsi que la caractérisation des profils des consommateurs constituent tout d'abord une première forme de cadrage du crack comme un problème public. Ce premier cadrage s'inscrit dans une perspective épidémiologique qui vise à définir le public tant du point de vue de son estimation chiffrée que de la caractérisation d'un profil socio-démographique.

Le discours médiatique sur le dénombrement du phénomène crack en France se présente depuis le milieu des années 1980, systématiquement sous l'angle d'une « menace imminente » avec le spectre de la situation américaine qualifiée dans les médias d'« épidémie de crack. » Cette sémantique contribue à un imaginaire marqué par la diffusion et la contagion du phénomène et une réponse exclusivement sécuritaire. Dès décembre 1989, le comité de coordination interministérielle de lutte contre la drogue (CILDT), ancêtre de la Mildeca, soulignait que la publicisation du crack dans les médias pouvait jouer un rôle d'incitation à la consommation en France, alors que le « problème » du crack n'était pas encore présent. Dans les médias, la consommation de crack aux États-Unis est présentée comme un phénomène lié à la paupérisation des grandes métropoles et de leurs périphéries (Porto 2022, Marchant 2013). Cet article paru dans *Libération* le 2 juin 1994 résume la manière dont le crack va tout d'abord être cadré comme une menace « épidémiologique » sous l'angle de la « menace » et de sa diffusion possible en France, et les défis que cette question pose en lien avec la « diabolisation » du phénomène aux États-Unis : « *Cette diabolisation du crack aura, et a encore, des incidences en Europe* ». « *Personne n'a cru à l'arrivée du crack en France parce qu'on n'y voyait pas les gens se mitrailler dans la rue, ainsi qu'on le racontait aux États-Unis* », explique Philippe Bordes. De même qu'il a fallu cinq ans aux Américains pour y croire, il faut attendre 1990 pour que la police française en reconnaisse l'existence. Entre 1993 et 1994, les saisies ont augmenté de 96 %. Le phénomène touche apparemment les milieux les plus défavorisés et

tend à se propager chez les héroïnomanes, dont il augmente, pour des raisons sans doute liées à la prostitution, les risques de contamination par le virus du sida. L'âge moyen des consommateurs serait de 29 ans. « *Le crack bénéficie du mystère qui l'entoure* », explique le docteur William Lowenstein, de l'hôpital Laënnec. « *Cette cocaïne du pauvre a emprunté les boulevards de l'héroïne. C'est un nouveau défi, alors que la politique de réduction des risques commence à être acceptée chez les héroïnomanes.* » Il est intéressant de noter que le cadrage épidémiologique du crack en France s'inscrit tout d'abord dans une logique de diffusion puis est associé à la question de la contamination par les maladies infectieuses, au départ en lien avec la transmission du VIH par le biais des liens établis entre crack et travail du sexe dans les années 1990 puis en lien avec la littérature sur la transmission de l'hépatite C par le biais du partage des pipes à crack et la présence de lésions aux mains et aux lèvres des consommateurs. Nous y reviendrons plus loin dans l'article.

Concernant le champ scientifique, le milieu des années 2000 constitue une période charnière dans le cadrage épidémiologique du phénomène du crack en France sous l'angle de la diffusion non plus comme une menace mais comme une réalité, dans la mesure où des tentatives de quantification basées sur des méthodes « robustes » se développent. Les travaux de recherche contribuent à ce cadrage épidémiologique, mais s'efforcent d'y intégrer de la complexité. Les estimations disponibles sur le nombre d'usagers de crack en France proviennent principalement des études statistiques³ menées par l'OFDT par le biais de ses différentes enquêtes (Escapad, Ena-Caarud). L'Observatoire faisait déjà état en population générale en 2005, d'une prévalence de l'usage de crack de 0,3 % auprès des 15-64 ans et de 0,7 % des 17 ans l'ayant expérimenté correspondant à une estimation nationale du nombre d'usagers de crack⁴ comprise entre 15 400 à 20 000 personnes. Parallèlement, ces études réalisées dans les structures accueillant les usagers de drogues estimaient en 2006

-
3. La méthode de capture et recapture est utilisée pour mobiliser d'une part, des données du recueil commun sur les addictions et les prises en charge (RECAP) dans les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) et d'autre part, le décompte annuel des usagers reçus dans les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (CAARUD).
 4. Ces estimations ne portent que sur la Métropole. Les données des départements d'outre-mer n'ayant pas été comptabilisées.

à près de 8 000 usagers consommant le crack dans les CAARUD d'après l'enquête nationale Ena-Caarud (Toufik, 2006). Quant au dispositif spécialisé en soins, pour la même période, sur les 62 000 personnes reçues, 1370 consommaient du crack (soit 2,4 % de la file active répartie principalement entre Paris (39 %) et la Guyane (20 %)). Une récente étude de l'OFDT (Janssen *et al.*, 2020) indique que le nombre des usagers de crack reçus dans les structures de prise en charge sanitaire en France a considérablement augmenté entre 2010 et 2017 passant de 3388 à 5143 (+52 %). L'estimation récente du nombre d'usagers de crack aurait triplé au cours de la même période (9775 personnes à 28 983) (Janssen *et al.*, 2020). Les dernières estimations produites par l'OFDT en 2019 sont de 42 800 usagers au niveau national dont environ 13 000 en Île-de-France. L'enquête ANRS-Coquelicot menée par l'Institut de Veille Sanitaire puis par l'Inserm contribue également à ce cadrage épidémiologique, en mettant en évidence l'importance du phénomène, un tiers des personnes fréquentant les CAARUD et les CSAPA recrutés dans l'enquête dès 2004 déclarent consommer du crack dans le dernier mois, ce qui en fait la substance illicite la plus consommée, après le cannabis (Jauffret-Roustide *et al.*, 2006). L'enquête Coquelicot va également contribuer au cadrage du crack comme un problème épidémiologique en mettant en évidence que l'un des principaux facteurs de risque de contamination par l'hépatite C est la consommation de crack (Jauffret-Roustide *et al.*, 2009). Les résultats de cette étude combinés à la volonté des acteurs de terrain d'adapter la politique de réduction des risques à la consommation de crack donneront lieu au développement de différents outils de prévention de la transmission de l'hépatite C, tel que le Kit Base développé par l'association EGO dès 2003, puis le Kit Crack développé par un collectif inter-Caarud et l'Inserm dès 2009 (EGO 2004, Jauffret-Roustide *et al.*, 2010).

Le cadrage épidémiologique du crack inclue également au-delà de l'estimation de la prévalence, des tentatives de caractérisation sociodémographique de ce public qui s'appuient ici principalement sur des données sociologiques qualitatives. Ainsi, le premier constat de la recherche Crack en Île-de-France est que les trajectoires des usagers de crack fréquentant les dispositifs de soins et de réduction des risques sont particulièrement marquées par la désaffiliation (Castel, 1994) qui inclut à la fois des liens distendus vis-à-vis du travail mais également vis-à-vis des relations sociales, en dehors des « mondes de la drogue ». Dans cette étude, la moyenne d'âge des

usagers de crack est de 42 ans (avec une amplitude large, oscillant entre 20 ans et plus de 60 ans), et les usagers sont en grande majorité des hommes. Les personnes rencontrées vivent, en très grande majorité, dans une situation de précarité sociale et économique très importantes, au moment où nous les rencontrons dans les enquêtes. Celle-ci se traduit par une absence de ressources financières issues d'un emploi, par des ruptures familiales, administratives et surtout par des difficultés de logement. Plus des deux tiers des usagers sont sans domicile fixe ou sont hébergés dans une structure sociale, ce qui est cohérent avec les études quantitatives menées sur le crack par l'Inserm telles que l'enquête ANRS-Coquelicot (Weill-Barillet *et al.*, 2016). Cette désaffiliation sociale très visible dans l'espace public ne résume toutefois pas la complexité du phénomène du crack et de ses publics en France. Ainsi, un article paru dans *Le Monde* le 21 janvier 1997 met en évidence la distinction entre les profils de publics consommant du crack, qualifiés de « marginaux » et ceux consommant de la cocaïne basée : *« Composant le dernier groupe, les “marginaux” se sont multipliés depuis l'apparition du crack, ce dérivé à bon marché de la cocaïne. En rupture d'activités sociales intégrées, ils font davantage penser aux héroïnomanes qui battent le pavé des grandes villes à la recherche d'une dose. Autant dire que les inégalités sont flagrantes entre ces divers groupes. En haut de l'échelle sociale, on sniffe de la poudre très pure, fournie par des dealers de luxe (service à domicile, possibilité de tester la marchandise avant achat). En bas, les résidus du crack, réchauffés, font encore plus de dégâts quand comme la pratique se répand ils sont injectés. Achetant en gros, les “huppés” paient le gramme de 50 à 100 francs, tandis que ceux du “marais” dépensent, au mieux, 500 francs pour un gramme de cocaïne à la pureté incertaine. Ultime inégalité, celle de l'impunité : les consommateurs de crack sont relativement plus souvent interpellés que les autres usagers de la cocaïne, généralement protégés des curiosités policières par une consommation opérée dans des endroits feutrés. »* Dans les imaginaires liés au crack, la précarité sociale est très présente, le crack étant souvent qualifié de « drogue ou cocaïne du pauvre ».

Les observations ethnographiques réalisées dans l'espace urbain, ainsi que les entretiens menés auprès des usagers et des professionnels, ont mis en évidence l'émergence relativement récente d'une population d'usagers de crack dits semi-insérés, voire insérés, autour des principales scènes de deal parisiennes et dionysiennes.

Ces observations sont confirmées par les entretiens menés auprès de professionnels qui constatent une évolution de leurs files actives. Ces discours font également écho à l'idée de diffusion : *« À vrai dire, la consommation du crack concerne tout le monde. Les profils sont diversifiés en termes de niveau d'insertion, de sexe et de catégories professionnelles. Toutes les associations le disent. L'image de la cheffe d'entreprise dans le 16^e arrondissement allant chercher son crack à la "colline" montre que toutes les couches sociales sont touchées »* (Professionnel, directeur de structure de réduction des risques, 75). Dans nos recherches, l'expression « usager inséré » ou « semi-inséré » ne renvoie pas uniquement à la catégorie économique « chef d'entreprise », mais à l'insertion sociale de la personne qui se traduit par l'existence des liens familiaux ou amicaux, l'accès à un logement, à une couverture sociale, le fait de disposer de revenus réguliers et éventuellement d'un travail. En creux, l'usager vivant en situation de précarité cumule un ensemble de difficultés liées à une insécurité pour le logement, à l'absence le plus souvent de liens sociaux et familiaux solides et surtout ne disposant de revenus issus d'un emploi. Il s'agit d'une typologie qui bien que caricaturale permet de caractériser certains profils et de dessiner des évolutions sociales relatives à la consommation de crack. Peu captée par les structures de réduction des risques, cette population semi-insérée est encore peu connue tant du point de vue de ses trajectoires biographiques que de ces pratiques. Notre étude met en évidence que ces publics semi-insérés fréquentent les structures de réduction des risques, essentiellement pour s'approvisionner en kits d'inhalation, et qu'ils semblent avoir déjà développé une forte addiction au crack et ont parfois entamé un processus de désinsertion vis-à-vis du logement, du travail ou de leur réseau social et familial. Pour le crack, l'une des interventions principales des intervenants en réduction des risques ou des acteurs de la prise en charge est donc de travailler sur l'insertion sociale des publics, en facilitant l'accès à l'hébergement ou au logement par des dispositifs de type « un chez soi d'abord », PHASE ou ASSORE. Un des éléments frappants de l'étude des trajectoires est par ailleurs la rapidité de la perte des liens sociaux et de la désinsertion sociale, pouvant être qualifiée de « dégringolade sociale ». D'après les récits des personnes consommatrices de crack rencontrées, le crack vient parfois remplacer un autre produit, comme pour venir combler un vide créé par l'arrêt d'une pratique antérieure, lui-même étant la résultante d'un événement ou d'une suite d'événements. La rencontre

avec le produit s'inscrit alors dans un moment de la trajectoire qui fait sens pour la personne, un « point de rupture » biographique ou *turning point* (Hughes, 1950, 1996). Ces tournants de l'existence, plus ou moins imprévisibles, prennent souvent une place importante dans la narration des usagers, surtout lorsqu'il s'agit d'évoquer leur carrière de consommation. Le parcours de vie des usagers semble avoir une incidence considérable sur la consommation des drogues. Chez certains, les ruptures familiales (divorce des parents, expulsion des enfants du domicile familial, décès d'un proche, perte de la garde des enfants, violences sexuelles, séquestration...) ont eu des incidences sur le maintien ou l'aggravation de la consommation. La trajectoire de cette femme consommatrice de crack rencontrée dans l'enquête Crack en Île-de-France est révélatrice de la complexité de la dimension de la précarité sociale dans les parcours. Les usagers que nous rencontrons dans les structures sont souvent en situation de précarité sociale, mais peuvent pour une partie d'entre eux s'inscrire dans des parcours de vie qui n'ont pas toujours été marqués par la précarité : *« Je travaillais dans la presse, j'étais iconographe. [...] enfin j'étais journaliste, je rédigeais aussi, photographe, iconographe, rédactrice et... ouais je travaillais et petit à petit j'ai fini par perdre tous mes boulots. – Parce que tu venais pas... ? – Oui, je venais pas... – Tu n'allais plus au boulot ? – Ouais, j'allais pas au boulot alors... forcément... ça passe une fois, deux fois, mais au bout d'un moment... j'étais pigiste, je faisais beaucoup de remplacements... donc après on rappelle plus, à force... Quand j'ai pu intégrer mon appartement, je me suis dit que j'allais m'arrêter, déjà c'est un peu loin de Paris quand même. Non seulement je suis loin de Paris, mais je suis loin de la gare, c'est à une demi-heure à pied pratiquement. [...] Donc c'est un frein quand même. [...] Mais... mais y'a des moments où je craque. Qu'est-ce qui te fait craquer en fait ? Eh bien, c'est le mal-être en fait. La plupart du temps, j'ai eu des consos festives, ça, c'était au début. Maintenant heu... je consomme pour pas penser, je consomme, je t'ai dit, y'a trop de mauvaises nouvelles depuis le début de l'année, neuf personnes sont mortes. »*

Le cadrage du crack comme un problème d'addiction : entre désintoxication forcée et réduction des risques

Un deuxième cadrage du crack comme problème public s'inscrit dans la sphère biomédicale de l'addiction et du « meilleur » traitement

à mettre en place pour ce public. Les discours présents dans l'espace médiatique vont le plus souvent opposer une approche en termes de traitement (caricaturée le plus souvent sous l'angle de la désintoxication forcée) et une approche de réduction des risques (réduite le plus souvent aux salles de consommation à moindre risque puis aux haltes soins addictions, leur nouvelle dénomination).

L'approche dichotomique qui revient à opposer centres de désintoxication « forcés » et réduction des risques est un cadrage très présent dans la sphère médiatique. Ainsi, à l'occasion d'une visite sur le site de La colline en 2018, Rachida Dati, la maire du 7^e arrondissement, élue Les Républicains est critique vis-à-vis de l'efficacité des salles de consommation à moindre risque, auxquelles elle oppose le soin : « Il n'y a pas de prises en charge des gens défavorisés. Il faut développer des centres de soins vraiment médicalisés. Moi je n'ai jamais cru aux salles de shoot » (BFM, 17 octobre 2018). Certains autres politiques parisiens tels que Pierre Liscia proposent une augmentation des places d'hébergement de désintoxication forcée pour les usagers de crack, avec une approche du soin guidée par une dimension de punition : « Un volet judiciaire doit impérativement y être associé pour pouvoir ordonner le placement en centres de désintoxication fermés de ces individus qui sont un danger pour eux-mêmes mais aussi pour la société. Contrairement aux salles de *shoot* qui alimentent les liens entre les toxicomanes et leurs dealers, la prise en charge sanitaire en centres de désintoxication permettrait de les rompre. Seul obstacle et non des moindres : de telles structures n'existent pas ! » (*Le Figaro*, 3 juin 2021). Ces propositions de centres de désintoxication forcée et d'éloignement des usagers hors de l'Île-de-France s'inscrivent également dans la lignée de propositions de Valérie Pécresse, la présidente Les Républicains de la région Île-de-France. Dans le cas du crack, il est intéressant de noter que son cadrage est particulièrement influencé par la prééminence d'un modèle biomédical de l'addiction sous l'angle de la perte de contrôle : le consommateur de crack parfois dénommé « crackeur » serait soumis à une condition pathologique qui l'emprisonnerait et définirait ses actes non pas comme le produit d'une volonté individuelle, mais comme le résultat de pulsions organiques sur lesquelles la personne n'aurait pas de contrôle. Le cadrage du crack comme problème biomédical peut également s'appliquer plus ou moins à toutes les drogues (licites et illicites) en fonction du processus de problématisation, publicisation et politisation du concept d'addiction depuis les années

1990 (Fortané, 2010). Mais pour le crack, la spécificité de ce cadrage sous l'angle du biomédical est, d'une part, des images stigmatisantes, comme celle du « crackeur » sans autocontrôle et, d'autre part, une difficulté à envisager une réponse biomédicale en termes de traitement qui puisse être efficace pour le crack. Cette perspective peut être qualifiée de « pessimisme productif » (Porto, 2022) qui renvoie l'idée selon laquelle les publics consommateurs de crack devraient bénéficier d'une approche exclusive de réduction des risques qui s'inscrit dans ce modèle biomédical issu de l'addictologie. Avec ce cadrage, la réduction des risques n'est envisagée pour ce public que comme un moyen pour réparer les risques et dommages causés par l'addiction sur le plan physique, psychologique, social, économique et relationnel.

Dans cette perspective, Emmanuel Grégoire, élu Parti Socialiste – premier adjoint à la Mairie de Paris en charge de l'urbanisme, de l'architecture, du Grand Paris, des relations avec les arrondissements et de la transformation des politiques publiques –, reconnaît la nécessité d'instaurer dans la ville des salles de consommation de crack encadrées par des équipes médico-sociales, afin de réduire les risques liés à cette pratique, mais en partant d'un constat d'échec sur les possibilités de sortie de l'usage : « Soyons réalistes, les crackeurs ont de très faibles chances de sortir durablement de la toxicomanie » (*Le Monde*, 2021). Anne Souyris, élue *Europe Écologie Les Verts* adjointe à la santé de la maire de Paris jusqu'en octobre 2023 propose quant à elle la réduction des risques comme un *mode d'accompagnement plus adapté pour les usagers éloignés des soins* : « Quand un grand consommateur ne veut pas être hébergé parce qu'il ne veut pas être loin de là où il achète son produit, la seule manière de commencer à le faire venir dans un processus de soins, c'est de l'accompagner dans cette consommation de manière supervisée et médicalisée » (*France Info*, 2 octobre 2021). Dans le même temps, elle élargit la perspective et met en évidence les difficultés de la prise en charge des usagers de crack en France, qui ne peut pas se réduire à une approche de santé publique et doit prendre en compte le contexte politique dans lequel ces pratiques d'usage se déroulent. Ainsi, dans un entretien au journal *Libération* en 2020, elle déclare : « On est le pays le plus prohibitionniste d'Europe, mais avec le taux de consommateurs le plus élevé. À un moment, il faut s'interroger et pas simplement interdire. »

Les données qualitatives que nous avons collectées dans l'étude « Crack en Île-de-France » montrent que l'expression des besoins en matière de prise en charge et de réduction des risques est bien plus complexe et nuancée que cette opposition entre centres de désintoxication forcée et salles de consommation à moindre risque. En effet, la plupart des usagers de crack rencontrés dans l'étude mettent en évidence dans leurs récits qu'ils souffrent d'une « addiction au crack » et font remonter leurs souhaits de se mettre à distance des produits, dans une démarche de « rétablissement », tout en ayant dans le même temps des demandes en matière de réduction des risques (accès à des espaces de consommation sécurisés et à du matériel stérile). Une de leurs demandes prioritaires pour mettre à distance le crack est de pouvoir bénéficier d'un hébergement éloigné des scènes de consommation. Cette femme consommatrice de crack relate une expérience de mise à distance du produit qui a été rendue possible grâce à une prise en charge globale en post-cure, après un premier échec lié à un sevrage sans accompagnement : « *Oui, c'est de mon plein gré. En fait, quand je consommais le crack, je faisais des sevrages de temps en temps. Parfois, je fumais pendant trois jours entiers, mon corps ne suivait plus, donc je me posais un peu. J'allais justement chez ma sœur jumelle, qui ne consomme pas. Je faisais des autosevrages [...]. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus, j'étais en train de mourir. J'étais toute maigre, j'étais faible et je me suis dit : faut que j'arrête parce que sinon, je vais y passer. Je commençais à y passer [...]. J'avais déjà fait une première cure avant pour l'alcool et le crack. Donc, j'étais retombée et là, j'ai choisi de faire cette deuxième cure. J'avais fait une première cure mais j'avais pas fait de post-cure. Donc, je me suis dit : pourquoi ça n'a pas marché ? Peut-être que j'aurais dû faire une postcure. Donc là, j'ai fait une deuxième cure de trois semaines à l'hôpital de Gare du Nord, Fernand Widal. Et après, je suis partie direct en postcure et je me suis dit : il faut t'éloigner du produit. Donc, je suis partie dans le nord. Je suis une pure Parisienne, je ne connais pas le nord, je me suis dit : ça peut être bien de changer. [...] J'en pouvais plus psychologiquement et physiquement.* »

La mise à distance nécessaire du « milieu du crack », la nécessité pour certains usagers de faire une pause dans la consommation pour infléchir les trajectoires et des exemples réussis de sorties d'un usage problématique du crack, ont été mentionnés à la fois par les professionnels et les usagers dans notre recherche. Du côté des usagers,

la mise en avant d'un désir de sevrage est également à interpréter comme un « idéal » de rupture avec des contextes de vie éprouvants et des parcours de vie fragilisés. Le sevrage peut être alors perçu par certains usagers comme un moyen de rompre avec cet univers de vie souvent marqué par la précarité, la violence, les traumatismes et les discriminations. Du côté des professionnels, ce sont plutôt des parcours vers des « usages régulés » qui ont été mis en avant, perçus comme des objectifs plus réalistes. Les facteurs favorisant ces parcours sont la nécessité d'un parcours fluide de la cure de sevrage en milieu hospitalier vers l'hébergement de moyenne ou longue durée en postcure, sans introduire de rupture temporelle dans le parcours de prise en charge et l'importance de proposer des projets à construire avec les usagers (hébergement, insertion, reconstruction des liens sociaux...).

Les usagers de crack déclarent également des besoins simples « se loger, se nourrir, être entourés » et mettre à distance les produits que l'emprise du « milieu » peut venir perturber. Ainsi cette femme usagère de crack mentionne que la consommation de crack est intimement liée à l'absence de logement et d'activité : *« Je pense que le premier besoin, c'est le logement. Je pense que c'est le logement parce que être dans la rue conduit à... Le fait de pas avoir d'endroit stable, je pense que ça pose problème. Quand on est dans la rue, c'est la vadrouille parce qu'on n'a pas d'endroit vraiment pour se poser. Donc, on va occuper nos journées en fumant du crack parce qu'on voit pas nos journées défiler en fumant du crack. »* Les dispositifs d'hébergement de type PHASE et ASSORE incluant accès au logement et accompagnement médico-social sont globalement appréciés par les usagers et décrits comme efficaces par les professionnels. Ces dispositifs d'hébergement permettent tout d'abord d'introduire une pause dans des vies chaotiques et rudes. Ils sont également particulièrement prometteurs concernant l'inflexion des trajectoires des usagers de crack vers l'insertion ou la (re)mise en place de liens sociaux, sanitaires et familiaux, quand ils incluent l'intervention de travailleurs sociaux, de psychiatres ou de psychologues. Au-delà de l'hébergement, la possibilité de faire des pauses dans des quotidiens très difficiles grâce à des espaces de repos est un élément essentiel dans la prise en charge, ce besoin a été exprimé à la fois par les usagers et les professionnels. Les espaces de repos sont des dispositifs essentiels à développer. Les nécessités d'être « occupés », de retrouver un sens à leur journée, d'être dans la vie sociale, ont été exprimées par de

nombreux usagers, ce que permettent des initiatives de type travail à la journée et la mise en œuvre d'activités à visée de reconstruction du lien social et d'insertion telles que Premières heures, TAPAJ ou Labo Fabrik.

Ainsi, si le cadrage de la prise en charge et de l'action publique portée par les politiques est le plus souvent réduit à une opposition entre désintoxication forcée et éloignement versus réduction des risques et salles de consommation à moindre risque, les expériences et discours des personnes consommatrices de crack et des professionnels met en évidence que l'expression des besoins va au-delà de cette dichotomie et met en évidence l'importance de prises en charge pluridisciplinaires, incluant réduction des risques et sevrage choisi dans une perspective de rétablissement.

Le cadrage du crack comme problème d'écologie urbaine : l'espace public partagé

Le troisième cadrage du crack comme problème public s'inscrit dans une perspective d'écologie urbaine. Le cadrage comme problème d'écologie urbaine s'inscrit dans une approche sociologique proposée par Robert E. Park et Roderick D. McKenzie dans le premier cours d'écologie urbaine de l'école de Chicago en 1924. Cette perspective analyse l'espace urbain comme un lieu de compétition et de coopération, d'accommodation et d'assimilation, entre différents publics sur un même territoire (Joseph, 2004). Ainsi, l'écologie urbaine considère la ville comme une agence de populations d'origines distinctes dans un même environnement et dans l'exercice d'un même système d'activités – où le concept de *compétition pour l'espace* se révèle crucial pour comprendre les problèmes sociaux de cohabitation et de co-présence (Joseph, 2004). Le cadrage du crack comme problème d'écologie urbaine renvoie en effet à la question du partage de l'espace public où co-existent différents usagers de cet espace tels que les riverains qui habitent dans des lieux résidentiels et les publics consommateurs de crack qui partagent cet espace comme lieu de vie. Cette dimension de la coexistence relève de l'ordre public, de l'administration de la ville, des relations de voisinage et du vivre ensemble, mais elle s'inscrit également en complémentarité et non en opposition avec le domaine de la santé publique.

Même si ce cadrage a pris de l'ampleur ces dernières années dans le champ médiatique en raison d'une forte médiatisation des scènes ouvertes de consommation de crack dans le Nord-Est parisien et dans le métro parisien, il est important de noter que le cadrage du crack comme problème d'écologie urbaine est présent dès les années 1980-1990. Il intervient avec la création des premières « scènes ouvertes » sur la place Stalingrad par exemple, phénomène qui s'est accentué dans les années 2000, avec les scènes les plus emblématiques, telles que la « Colline du crack », les « Jardins d'Éole » ou « le camp de Forceval ». Ces scènes ouvertes sont renforcées par l'intervention des forces de l'ordre qui les démantèlent puis les déplacent, ce qui fait que ce phénomène se reproduit en permanence dans différents interstices de la ville et de sa périphérie. Ces scènes ouvertes sont généralement envisagées sous l'angle des troubles à l'ordre public pour les riverains, mais elles génèrent également des problèmes de sécurité publique et de santé publique pour les personnes consommatrices de crack qui sont exposées à de la violence et vivent dans des conditions d'hygiène déplorables.

Dans ce cadrage du crack comme problème d'écologie urbaine, les acteurs concernés sont plus nombreux que pour les autres cadrages. Le crack devient alors un espace de préoccupations, discussions, controverses entre des acteurs de la sphère sanitaire, sociale et de la sécurité publique. Ainsi, en réponse aux discours marqués par une réponse exclusivement sécuritaire, un collectif d'associations de réduction des risques, d'habitants et de professionnels a lancé un appel le 26 mai 2021 dans le journal *Le Monde*. Cet appel met en lumière la force des mobilisations autour de la question du crack. Il condamne la « longue série de déplacements de scènes ouvertes depuis l'émergence de la consommation de crack en Île-de-France au début des années 1990, alors que la place Stalingrad était déjà le principal lieu de rencontre ». Dès les années 1990, les difficultés de cohabitation dans l'espace public entre les riverains et les personnes qui consomment du crack avaient donné lieu à la création de collectifs de riverains tels que le collectif anti-Crack et Stalingrad Quartier Libre au début des années 2000. Vingt ans après, différents collectifs se sont créés autour de la scène ouverte de Forceval, dans le sillage des mouvements sociaux créés dans le cadre de la contestation des salles de consommation à moindre risque vers 2013 et ont considérablement diversifié leurs formes de mobilisations et répertoires d'action (Jauffret-Roustide *et al.*, 2018 ; Houborg *et al.*, 2022). L'argumentaire

de l'appel du 26 mai 2021 met en évidence la complexité du discours des collectifs de riverains en montrant que la réponse sécuritaire éloigne les usagers de crack du soin et ne mettait pas fin aux scènes ouvertes. À ce problème d'écologie urbaine, la réduction des risques se présente également comme une réponse à la question de la tranquillité publique (et pas uniquement à la santé publique) avec l'offre d'espaces adaptés à la consommation, articulés à d'autres dispositifs d'hébergement. Les données relatives à l'évaluation de ces dispositifs de réduction des risques en France ont mis en évidence à la fois la réduction des overdoses et des maladies infectieuses, mais également la réduction des injections dans l'espace public, qui constituent une diminution des troubles à l'ordre public et une pacification de l'espace public (Jauffret-Roustide *et al.*, 2021).

Cette thématique des scènes ouvertes de crack et du cadrage du crack comme un problème d'écologie urbaine occupe une place prépondérante dans le discours des politiques, et plus particulièrement lors des échéances électorales (Jauffret-Roustide, 2021). Durant de nombreuses années, ce sont les enjeux du trafic de drogues qui ont essentiellement été mis en avant comme la cause de l'insécurité dans les discours politiques sur les drogues (Comelli *et al.*, 2021). Plus récemment, la figure des personnes consommatrices a été mobilisée non plus uniquement sous l'angle du « fauteur de troubles ». En miroir de l'usager « fauteur de troubles » s'est développée la figure du riverain comme « victime », nouvelle figure très présente dans le débat public, à la fois dans le débat politique et médiatique. Ainsi, lors des municipales de 2020, certaines personnalités politiques, comme Rachida Dati, maire Les Républicains (LR) du 7^e arrondissement de Paris et l'élu parisien Pierre Liscia, candidat sans étiquette ont lancé un appel « contre le “fléau du crack” à Paris ». Une année plus tard, Pierre Liscia fait du crack un sujet politique de la campagne des municipales en déclarant : « Aujourd'hui, en plus des problématiques liées à l'insécurité chronique, à la saleté vertigineuse et l'extrême précarité du quartier, sont venus s'ajouter le fléau du crack et le chaos migratoire. Ce quartier est devenu une poudrière ! Depuis longtemps, je préconise un plan d'urgence contre le crack qui vise à apporter une réponse sanitaire et sociale à des personnes très largement désocialisées et malades de leur addiction. Aujourd'hui, il n'existe aucune structure pour sortir les toxicomanes de la rue et des mains de leurs dealers et les accueillir dans un parcours de soins au long cours » (*Le Figaro*, 11 octobre 2019). Quelques années plus tard, en juin 2021, il

mentionne l'abandon des riverains par les pouvoirs publics en utilisant la rhétorique suivante : « les autorités ont fait le choix d'institutionnaliser une nouvelle colline du crack en plein Paris ». Il met au centre de son discours la figure du riverain comme victime dans un article du *Figaro* daté du 3 juin 2021 : « Depuis 3 ans, le gouvernement et la Ville de Paris se sont contentés de déplacer le problème de quartiers en quartier : porte de La Chapelle, porte d'Aubervilliers, tunnel de Rosa Parks, Stalingrad, jardins d'Éole... À chaque fois, ce sont les habitants qui trinquent pour le résultat que l'on connaît aujourd'hui : tout un quartier de Paris sinistré, des riverains abandonnés et des commerces à l'agonie... Le gouvernement et la Ville ont fait le choix d'institutionnaliser une nouvelle colline du crack au cœur d'un quartier très résidentiel où vivent beaucoup de familles. On dénombre près d'une trentaine d'établissements qui accueillent des enfants – crèches, haltes-garderies, écoles maternelles et primaires, collèges – dans un rayon de 300 mètres autour du parc Éole. Pour moi, il y a mise en danger délibérée de la vie d'autrui ! Les agressions verbales et physiques sont quotidiennes pour les riverains, tous comme les rixes entre toxicomanes. Le chemin des écoliers est devenu un chemin de croix que les parents et leurs enfants redoutent. Pour beaucoup d'entre nous, la moindre sortie, même la plus anodine pour faire ses courses ou promener son chien, est synonyme de stress et d'angoisse. Nous vivons en permanence dans un climat pesant et oppressant. Les plus vulnérables et les femmes se sentent privés de la liberté la plus élémentaire d'aller et venir dans leur propre quartier. »

En réponse à ce problème d'écologie urbaine, la ville de Paris, la Préfecture de Paris, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France et la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca) ont appelé à une forte mobilisation sanitaire et sécuritaire et mis en œuvre en 2019 un plan qui s'inscrit dans la lignée historique d'États généraux organisés dès 2005 à Paris.

Conclusion

Nos recherches mettent en évidence que la question du crack est l'objet d'un triple cadrage qui s'efforce de répondre à trois « problèmes » qui appellent une réponse des pouvoirs publics. Tout d'abord, nous avons identifié que le crack pouvait être cadré comme un *problème épidémiologique*, identifié au milieu des années 1980,

à partir de la diffusion de la consommation de crack auquel s'ajoute une dimension de prévention des maladies infectieuses à partir des années 2000 en lien avec l'identification de la possible transmission du crack dans l'épidémie d'hépatite C par le biais du partage des pipes à crack. Ensuite, le crack peut également être cadré comme un *problème de prise en charge*, favorisé par l'essor de l'addictologie en tant que nouvelle spécialité médicale en France dans les années 1990 et du mouvement social de la réduction des risques qui s'est développé dans le cadre de l'épidémie de VIH au milieu des années 1980. Ce cadrage va s'efforcer de chercher à trouver une prise en charge adaptée entre des politiques de réduction des risques et de prise en charge (incluant des espaces d'inhalation, des traitements de substitution au crack et centres de désintoxication forcée). Enfin, le crack peut être également cadré comme un *problème d'écologie urbaine*, résultant de la coexistence souvent difficile entre les usagers et les riverains des quartiers les plus touchés par la consommation et la vente de drogue.

Nos travaux de recherche montrent l'importance de la politique de réduction des risques (salles d'inhalation, de repos, etc.) qui permettent aux publics consommateurs de crack de rester en vie. Il est également important de pouvoir y associer des dispositifs permettant d'y inclure la sortie possible et volontaire de l'addiction. Cela nécessite le développement des centres de cure et de postcures permettant aux usagers de quitter le terrain qui les ramène à l'addiction et également de bénéficier d'une véritable prise en charge incluant à la fois les phénomènes d'addiction, les troubles psychiatriques et la réhabilitation sociale (par l'accès à l'hébergement, mais également l'accès à des activités d'insertion). Il s'agit cependant d'objectifs de moyen et long terme qui peuvent également répondre à moyen et long terme à la question des troubles à l'ordre public. Dès lors, il faut considérer que le seul déplacement des usagers est contre-productif et avancer vers des stratégies dont les effets ne sont pas contradictoires, peut-être en envisageant des zones d'accueil suffisamment nombreuses et pérennes. Le plan de mobilisation coordonné sur la problématique du crack, associant la préfecture d'Île-de-France, le parquet de Paris, la préfecture de police, la MILDECA et l'ARS, constitue une occasion historique d'élaborer une réponse à la fois globale et de long terme, mais elle doit privilégier une réponse de santé publique et d'inclusion sociale pour les publics qui consomment du crack pour bénéficier à long terme d'un impact de pacification de l'espace public.

Bibliographie

- Bless, R, Korf, D. J. & Freeman, M. (1995). Open drug scenes: a cross national comparison of concepts and urban strategies. *European Addiction Research*, 1(3), 128-138.
- Bourgois, P. (1992). Une nuit dans une « shooting gallery » : enquête sur le commerce de la drogue à East Harlem. *Actes de la recherche en sciences sociales*, 94, 59-78.
- Bourgois, P. (1998). The moral economies of homeless heroin addicts: confronting ethnography, HIV risk, and everyday violence in San Francisco shooting encampments. *Substance Use & Misuse*, 33(1), 2323-2351.
- Cadet Taïrou, A. et Jauffret-Roustide, M. (dir) (2021). Rapport de l'étude Crack en Seine, Inserm-OFDT, janvier, 200 p.
- Castel, R. (1994). La dynamique des processus de marginalisation : de la vulnérabilité à la désaffiliation. *Cahiers de recherche sociologique*, 22, 11-27.
- Céfaï, D. (1996). La construction des problèmes publics : définitions de situations dans des arènes publiques. *Réseaux*, 14(75), 43-66.
- Céfaï, D. (2017). Públicos, problemas públicos, arenas públicas... O que nos ensina o pragmatismo (Parte 1). *Novos Estudos Cebrap*, Parte 1, v. 36, n. 1. p. 187-213/ Parte 2, v. 36, n. 2, p. 129-142.
- Céfaï, D. (2019). Les problèmes, leurs expériences et leurs publics : une enquête pragmatiste, in Sociologie et sociétés, Montréal, printemps-automne. *Sociologie et sociétés*, 51(1-2), 33-92.
- Charles-Nicolas, A. (1997). *Crack et cannabis dans la Caraïbe. La roche et l'herbe*. Paris, L'Harmattan.
- Comelli, C, Campion, G. et Jauffret-Roustide, M. (2021). Le traitement médiatique des drogues dans la presse quotidienne française (2013-2018). *EchoGéo*, septembre 2021.
- EGO. (2004). Rapport d'évaluation du Kit Base. Le Kit Base, un nouvel outil pour la réduction des risques, Novembre.
- Fortané, N. (2010). La carrière des « addictions » : d'un concept médical à une catégorie d'action publique. *Genèses*, 1(1), 5-24.
- Gusfield, J. (1981). *The culture of public problems: Drinking-Driving and the Symbolic Order*. Chicago, University of Chicago Press.
- Houborg, E. & Jauffret-Roustide, M. (2022). Drug consumption rooms: welfare state and diversity in social acceptance in Denmark and France. *American Journal of Public Health*, 112(2), 159-165.
- Hughes, E. (1996). Carrières, cycles et tournants de l'existence. In Everett C. Hughes, *Le regard sociologique*, textes rassemblés et présentés par Jean-Michel Chapoulie (pp. 165-173). Paris, Éditions de l'EHESS. Trad. de « Cycles, Turning Points, and Careers », communication présentée à la 8^e conférence annuelle de Theology in Action, South Byfield, Massachusetts, septembre 1950 (et reprise dans l'ouvrage *Sociological Eye*, Transaction Books, 1971).

- Ingold, F. R. & Toussirt, M. (1994). La consommation du crack à Paris en 1993, Données épidémiologiques et ethnographiques. Paris, IREP.
- Janssen, E., Cadet-Taïrou, A., Gêrôme, C. & Vuolo, M. (2020). Estimating the size of crack cocaine users in France: Methods for an elusive population with high heterogeneity. *International Journal of Drug Policy*, 76, art. 102637.
- Jauffret-Roustide, M., Couturier, E., Le Strat, Y., Barin, F., Emmanuelli, J., Semaille, C., Quaglia, M., Razafindratsima, N., Vivier, G., Oudaya, L., Lefevre, C. & Desenclos, J.-C. (2006). Estimation de la séroprévalence du VIH et du VHC et profils des usagers de drogues en France. *Bulletin épidémiologique hebdomadaire*, 33(5), 244-247.
- Jauffret-Roustide, M., Le Strat, Y., Couturier, E., Thierry, D., Rondy, M., Quaglia, M., Razafandratsima, N., Emmanuelli, J., Guibert, G., Barin, F. & Desenclos, J.-C. (2009). A national cross-sectional study among drug-users in France: epidemiology of HCV and highlight on practical and statistical aspects of the design. *BMC Infectious Diseases*, 9, 113-124.
- Jauffret-Roustide, M., Rondy, M., Oudaya, L., Guibert, G., Semaille, C., Pequart, C. et le collectif inter-CAARUD sur le crack (2010). Une enquête auprès des consommateurs de crack en Île-de-France. Retour d'expérience sur un outil de réduction des risques pour limiter la transmission du VIH et des hépatites, BEHWeb (1).
- Jauffret-Roustide, M. (2011). Les salles d'injection, à la croisée de la santé publique et de la sécurité publique. *Métropolitiques. Revue électronique internationale de sciences sociales sur les politiques urbaines*, mars.
- Jauffret-Roustide, M. & Cailbault, I. (2018). Drug consumption rooms: comparing times, spaces and actors in issues of social acceptability in French public debate. *International Journal of Drug Policy*, 56(June), 208-217.
- Jauffret-Roustide, M. (2021). Drogues dans l'espace public : quelle éthique de la ville pour les candidats aux présidentielles. *The Conversation*, 3 octobre 2021.
- Jauffret-Roustide, M. (2023). Crack et cocaïne : pourquoi deux drogues si proches sont-elles traitées si différemment dans la sphère publique. *The Conversation*, 19 juillet 2023.
- Joseph, I. (2004). Goffmann et l'écologie urbaine. *Les Annales de la recherche urbaine*, 95, 130-133.
- Porto De Avezuedo Marinho, C. (2022). *Os usurarios sao atores de seu acompanhamento : a situacao de reducao de riscos em Paris, França*. Thèse d'anthropologie, Rio de Janeiro, EHESS.
- Toufik, A. et al. (2006). *Profils, pratiques des usagers de drogues*. Paris, Ena-CAARUD, OFDT.
- Weill-Barillet, L., Pillonel, J., Pascal, X., Semaille, C., Léon, L., Le Strat, Y., Barin, F., Jauffret-Roustide, M. (2016). Hepatitis C Virus and HIV seroprevalences, sociodemographic characteristics, behaviors and access to syringes among drug users, a comparison of areas in France, ANRS-Coquelicot Survey. *Revue d'Epidémiologie et de Santé Publique*, Sep ; 64 (4): 301-12.